

### Información Paciente

**Nombre** : Luis Christopher Benois Araya  
**Edad** : 41a 5m 20d  
**Dirección** : Pilcomayo Block 923 Dpto 322

**Rut** : 14.126.293-9  
**Fecha Nacto**: 09/04/1981  
**Comuna** : La Florida

**N° Archivo** : 1508757  
**Sexo** : Masculino  
**Teléfono** : 9 9516 5279

**N° Epicrisis**  
**323716**

### Información Hospitalización

**Unidad de Ingreso** : Upc - Uci Adulto

**Fecha Ingreso** : 07/09/2022 17:42

**Días Estadía**: 22

**Unidad de Egreso** : Upc - Uci Adulto

**Fecha Egreso** : 29/09/2022 03:09

### Motivo o Diagnóstico de Ingreso

disnea

### Comorbilidades

### Procedimientos

### Intervenciones Quirúrgicas

### Epidemiología

### Resumen Clínico

#### RESUMEN DE EGRESO UCI

Nombre: Luis Benois Araya  
RUT: 14126293-9  
Edad: 41 años  
FI CASR: 07/09/22  
FI UPC: 09/09/22  
FE UPC: 29/09/22  
Contacto: Juan (amigo) 934087212

#### Antecedentes:

- Mórbitos: PPVI en mal control con CV 567.000 y CD4 42 (31/08/22), sífilis latente en tratamiento. Coinfecciones. IgG toxo (-), VHB y VHC (-).
- Quirúrgicos: no refiere
- Fármacos: TARV (tenofovir difumarato, emtricitabina y dolutegravir) reiniciada hace 1 semana. Paracetamol, ketoprofeno, neurobionta.
- Alergias: niega
- Hábitos: TBQ suspendido hace 3 meses, OH social, Drogas: THC diario.
- Hospitalizaciones recientes: no
- Inmunizaciones: Niega

#### Historia de ingreso:

Paciente con antecedentes descritos. Consulta por cuadro de 1 semana de evolución de fiebre, mialgias, dificultar respiratoria progresiva y tos sin expectoración, asociado a dolor tipo puntada con tope inspiratorio.

Ingresa en malas condiciones, taquicárdico (149), hipotenso (82/40), afebril, saturando 71° ambiental. Al examen físico se describe deshidratado, bien perfundido con MP (+) y crépitos bibasales. Exámenes de ingreso destaca con parámetros inflamatorios elevados (PCR 237, GB 18.420) con LDH elevada (731), láctico 41 e hiponatremia leve (130), PCR COVID negativa. TAC de tórax con extensas opacidades pulmonares bilaterales.

Evaluated por infectología se decide terapia empírica con cotrimoxazol, antibióticos de primera línea y corticoides.

En UEA evoluciona con aumento de requerimiento de O2 con CNAF hasta FiO2 65%, PaFi 177. Ingresa a UPC para continuar

**Fecha Epicrisis** : 29/09/2022 03:11

manejo.

### Diagnósticos de ingreso:

1. Insuficiencia respiratoria aguda parcial
  - a. Neumonía en paciente inmunosuprimido
  - b. Obs. PCP
2. Antecedentes

### Planes:

Hemodinamia: Estable, sin requerimiento de DVA. Monitorización invasiva, vigilancia de BH y diuresis.

Respiratorio: Insuficiencia respiratoria aguda determinada por neumonía multilobar. Ingresó para VMI, se medica con fentanilo 300 mcg, etomidato 20 mg y rocuronio 100 mg. Se instala TOT #8 a 22 cm de CL y se conecta a ventilador con parámetros protectores (VT 400 FR 22 PEEP 30 DP 8). Se inicia sedoanalgesia con fentanilo y propofol. (P) control de Rx tórax y GSA. Mañana eventual LBA.

Se mantienen corticoides y antibióticos.

Evoluciona de manera satisfactoria inicialmente, por lo que se avanza en weaning, con buena respuesta y se extuba el 10/09. Evoluciona de manera desfavorable, debiendo reintubarse a las 12 hrs de extubación. Se solicita TC columna para descartar Espondilodiscitis

Con evidente caída de la PAFI, se decide pronar el día 11/09

Se mantiene en prono hasta el 18/09 y se supina con PAFI 240 siempre con buena Compliance y con buena respuesta a maniobras de reclutamiento, pero poco duraderas. Se suspende BNM con lo que nuevamente se produce caída de PAFI y comienza con muy mala mecánica ventilatoria, por lo que se decide volver a bloquear. Se solicita AngioTAC de tórax que evidencia TEP multisegmentario bilateral, por lo que se inicia anticoagulación. Persiste con mal intercambio, requiriendo VMI protectora, manteniendo PAFI entre 90 y 140 durante última semana. Se decide nuevo ciclo de prono el 26.09, con escasa respuesta, sin lograr mejora de PAFI por sobre 150mmHg.

Infeccioso: PPVI con mala adherencia a TARV. Cursando neumonía multifocal, del estudio: PCR Covid-19 (-), GeneXpert TBC (-), PCR PCP en gárgaras (P), hemocultivos (P), UC (P). Eventual LBA para completar estudio microbiológico.

Se mantiene cobertura empírica con ceftriaxona + cotrimoxazol.

Lo objetivo es PCP en LBA 14/09 (206.000 copias) resto (CMV -HSV - TB -GMN todo negativo) por lo que se mantiene cotrimoxazol EV y en CAET del 12/09 KPN BLEE > 1.000.000 UFC, recibe corticoides en dosis adecuadas más de su equivalente a dosis de 20 mg/d de PDN como corresponde en esta fase., se aumentan dosis de Imipenem por fenómeno sugerente de cavitación en base izquierda al igual que condensaciones. Mantiene TTO con TARV sin cambios.

Sin sustrato para mantener Vanco micina. PCR con aumento 60-> 157. Ante falta de respuesta ATB, se toman nuevos cultivos y ante quiebre clínico, se decide dar en forma empírica Colistin, suspendiéndose a las 36 hrs por resultados de cultivos, persistiendo presencia de KPN BLEE en CAET. Se decide incrementar dosis de Imipenem, logrando disminuir parámetros inflamatorios de 300 a 187.

Renal: sin conflicto ELP relevante, debitos urinarios aumentado a expensas de furosemida con lo cual queda ligeramente negativo. Dado uso de Colistin, presenta NTA secundaria.

Mala evolución a pesar de máximos esfuerzos médicos, paciente fallece el 29.09.2022 a las 2:45hrs, acompañado de familiares. Se extiende certificado de defunción

### Diagnósticos Egreso

- Insuficiencia respiratoria global aguda severa
- oSDRA ¿ IOT 08/09; Extubación fallida 09/09
- oNeumonía en IS por VIH
- §PCP
- oNAVM por K. pneumoniae BLEE
- oTEP segmentario y subsegmentario bilateral
- Antecedentes: VIH con mal control CD4 40; Sífilis latente

### Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria aguda - Insuficiencia respiratoria global aguda severa  
oSDRA ¿ IOT 08/09; Extubación fallida 09/09  
oNeumonía en IS por VIH

Fecha Epicrisis : 29/09/2022 03:11

# Epicrisis Hospitalaria

## ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 29-09-2022 3:11:46

Página 3 de 3

§PCP  
oNAVM por K. pneumoniae BLEE  
oTEP segmentario y subsegmentario bilateral  
-Antecedentes: VIH con mal control CD4 40; Sífilis latente

**Condición de Egreso** Fallecido

**Egreso con Catéter Doble J:NO**

fallecido

**Plan Post Alta**

fallecido

**Indicaciones**

**Tipo de Reposo** :

**Régimen Alimentario** :

**Medicamentos** :

**Controles**

INTERNO

Becado/Residente



Gonzalo Núñez Muñoz  
**Médico Tratante (Staff)**

Fecha Epicrisis : 29/09/2022 03:11

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:03

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar